

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

eliglustat tartrate (as eliglustat 84.4mg)

(세레텔가캡슐84밀리그램, (주)젠자임코리아)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1캡슐 중 eliglustat 84.4mg

☐ **효능 효과 :**

- CYP2D6 느린 대사자(PM), 중간 대사자(IM) 혹은 빠른 대사자(EM)로서 1형 고셔병(GD1) 성인 환자의 장기간의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제11차 약제급여평가위원회 : 2017년 9월 13일

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2017년 6월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 전, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “CYP2D6 느린 대사자(PM), 중간 대사자(IM) 혹은 빠른 대사자(EM)로서 1형 고셔병(GD1) 성인 환자의 장기간의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하고 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■■¹⁾) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “CYP2D6 느린 대사자(PM), 중간 대사자(IM) 혹은 빠른 대사자(EM)로서 1형 고셔병(GD1) 성인 환자의 장기간의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 “imiglucerase, velaglucerase”가 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 1형 고셔병(GD1)에 허가받은 경구제로 β -glucocerebrosidase 효소의 기질이 합성되는 것을 막는 기질 감소 요법(Substrate reduction therapy, SRT) 치료제임.²⁾³⁾⁴⁾
- 신청품은 교과서⁵⁾⁶⁾⁷⁾와 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 고셔병의 치료제로 언급되고 있음.
- [ENCORE]¹¹⁾ 3년 이상 ERT 치료를 받아 고셔병의 치료목표¹²⁾에 도달한 만 18세 이상 성인 환자(n=160)을 대상으로 신청품과 imiglucerase를 비교한 비열등 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 혈액학적 변수와 각 장기의 용적이 안정화¹³⁾된 환자의 백분율(%)에서 신청품군은 imiglucerase군 대비 비열등성을 입증하였음. (비열등마진: -25%, PP분석: 85% vs 94%, [95% CI] -17.6 to 4.2, ITT분석: 83% vs 91%, [95% CI] -17.1 to 5.1)
 - ✓ 복합 변수를 구성하는 각 개별 평가변수 관련하여, 혈소판 수치, 비장 용적, 간 용적 관련하여 신청품군과 imiglucerase군간에는 통계적으로 유의한 차이가 없었고(P>0.2), 헤모글로빈 농도 관련하여, 신청품군과 imiglucerase군간 차이의 신뢰구간의 하한치(-5.2g/L)는 임상적으로 의미있는 수치가 아님.

- 대부분의 부작용은 심각하지 않았고 경증 또는 중등도였음.
- [관찰연구결과]¹⁴⁾ ENCORE 임상시험의 관찰연구 결과, ENCORE 임상시험 이후 eliglustat 치료를 지속한 고셔병 환자(n=157)들은 복합 평가변수 및 개별 평가변수 모두에서 4년까지 임상적인 안정성을 유지하였으며, 평균 10년간의 효소 치료를 통해 달성한 baseline 수치로부터 임상적으로 의미 있는 변화는 없었음.
- [ENGAGE]¹⁵⁾ 치료를 받지 않은 만16세 이상의 제1형 고셔병 환자(n=40)를 대상으로 신청품과 위약을 비교한 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 비장용적 변화율에서 신청품군은 27.77% 감소(95% CI, -32.57% to -22.97%)하였고 위약군은 2.26% 증가(95% CI, -2.54% to 7.06%)하여 신청품군에서 위약군 대비 유의한 개선을 보였음.(treatment difference -30.03%, 95% CI, -11.37% to -1.91%; P=0.007)
 - 2차 평가지표인 헤모글로빈수치, 간 용적, 혈소판 수에서 신청품군은 위약군 대비 유의한 개선을 보였음.
 - ✓ 헤모글로빈수치: 신청품군은 0.69g/dL 증가하였고 위약군은 0.54g/dL 감소하여 군간 차이는 1.22g/dL(95% CI, 0.57g/dL to 1.88g/dL, P<0.001)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음.
 - ✓ 간 용적: 신청품군은 5.2% 감소하였고 위약군은 1.4% 증가하여 군간 차이는 -6.64%(95% CI, -11.37% to -1.91%, P<0.007)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음.
 - ✓ 혈소판 수: 신청품군은 32.0% 증가하였고 위약군은 9.1% 감소하여 군간 차이는 41.06%(95% CI, 23.95% to 58.17%, P<0.001)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음.
- 사망이나 심각한 이상반응은 없었고, 모든 TEAE(treatment-emergent adverse event)는 경증-중등도였음.
- 관련 학회에서는, 신청품은 임상시험을 통해 ERT 대비 비열등성을 입증하였으며, 경구제라는 편리함이 있어 2주마다 주사를 맞지 않아도 되는 편의성 개선의 이점을 가지고 있어, 환자의 삶의 질 향상에 기여할 수 있다는 의견을 제시하였음.¹⁶⁾¹⁷⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “CYP2D6 느린 대사자(PM), 중간 대사자(IM) 혹은 빠른 대사자(EM)로서 1형 고셔병(GD1) 성인 환자의 장기간의 치료”에 허가받은 약제로, 현행 급여기준에서 고셔병의 1차 치료제로 인정되고 있는 imiglucerase, velaglucerase를 대체 가능 약제로 선정함.

- 신청품은 대체약제와 효과가 유사하고¹⁸⁾, 신청품의 일일 투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일 투약비용(■■■■원) 대비 저렴하므로 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■원/캡슐임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■원/캡슐임.¹⁹⁾

○ 재정영향

- 신청품의 대상 환자수는 약 ■■■명이고²⁰⁾, 제약사 제시 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이며, imiglucerase, velaglucerase의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원 감소할 것으로 예상됨.²³⁾

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 프랑스, 독일, 미국, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood Eighth Edition(2015)
- 3) Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics Sixth Edition(2013)
- 4) Rheumatology Sixth Edition(2015)
- 5) Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood Eighth Edition(2015)
- 6) Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics Sixth Edition(2013)
- 7) Rheumatology Sixth Edition(2015)
- 8) Paige Kaplan et al. Revised recommendations for the management of Gaucher disease in children, Eur J Pediatr (2013) 172:447 - 458
- 9) Nadia Belmatoug et al. Management and monitoring recommendations for the use of eliglustat in adults with type 1 Gaucher disease in Europe. Eur J Intern Med (2016) Aug 10.
- 10) Young Bae Sohn et al. Substrate reduction therapy as a new treatment option for patients with Gaucher disease type 1: A review of literatures. J Genet Med 2016;13(2):59-64
- 11) Richard G et al. Secukinumab in Plaque Psoriasis – Results of Two Phase 3 Trials. N Engl J Med 2014;371:326-38.
- 12) 1)헤모글로빈 농도 : (여성)110g/L이상, (남성)120g/L이상, 2)혈소판 수 : 100x10⁹/L이상, 3)비장 용적이 정상치의 10배 미만이거나 무작위 배정 전 비장전절제술을 받은 지 3년이 초과, 4)간 용적이 정상치의 1.5배 미만, 5)뼈의 위기(bone crisis)나 증상성 골 관련 질환(1년 이내에 골괴사로 인한 통증이나 병적골절)이 없음
- 13) 1)헤모글로빈 농도 : 15g/L이상 감소하지 않음, 2)혈소판 수 : 25%이상 감소하지 않음, 3)비장 용적: 25% 이상 증가하지 않음, 4)간 용적: 20% 이상 증가하지 않음
- 14) Cox TM et al. Eliglustat maintains long-term clinical stability in patients with Gaucher disease type 1 stabilized on enzyme therapy. Blood. 2017; 129(17): 2375-2383
- 15) Pramod K et al. Effect of oral eliglustat on splenomegaly in patients with Gaucher disease type 1: the ENGAGE randomized clinical trial. JAMA. 2015 Feb 17;313(7):695-706
- 16) 대한내분비학회([REDACTED], [REDACTED])
- 17) 대한의학유전학회([REDACTED], [REDACTED])
- 18) Cox TM et al. Eliglustat compared with imiglucerase in patients with Gaucher's disease type 1 stabilised on enzyme replacement therapy: a phase 3, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2015 Jun 13; 385(9985):2355-62
- 19) [REDACTED]
- 20) 2014-2016년도 EDI 청구 환자수[imiglucerase, velaglucerase을 청구한 만19세 이상 환자수]에서 CAGR을 산출하여 당해연도(2017년도) 기준 대상 환자수를 산출함.
- 21) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도:[REDACTED]캡슐, 2차년도:[REDACTED]캡슐, 3차년도:[REDACTED]캡슐)
- 22) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 23) 재정증감액 = (신청약가-신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) x 제약사 제출 예상 사용량